ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

OFTALMOLOGÍA

90 preguntas de práctica

Ojo Rojo, Glaucoma & Retina

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Oftalmología · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR					
2.01.1.097	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5, Q6	Tomo 15 · 15.1 (Pág. 5)
6.02.1.002	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12	Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11)
6.02.1.004	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q13	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.005	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q9	Tomo 15 · 15.2 (Pág. 9)
6.02.1.006	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 15 · 15.4 (Pág. 13)
6.02.1.007	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q10	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.008	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q11	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.009	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.011	Estrabismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 15 · C.23 (Pág. 50)
6.02.1.015	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.019	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q15	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.024	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 15 · C.16 (Pág. 36)
6.02.1.029	Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.007	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.010	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
BLOQUE 2: SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR					
2.01.1.005	Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35, Q36	Tomo 15 · 15.8 (Pág. 26)
6.02.1.002	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27, Q31, Q32	Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11)
6.02.1.012	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 15 · C.24 (Pág. 52)
6.02.1.013	Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33, Q34	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.014	Hifema	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.021	Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21, Q22, Q23	Tomo 15 · 15.5 (Pág. 15)
6.02.2.005	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.006	Hemorragia vítrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 3: GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO					
6.02.1.003	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47	Tomo 15 · 15.10 (Pág. 33)
6.02.1.018	Obstrucción completa de la vía lacrimal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.031	Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q51	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.003	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.004	Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49, Q50, Q52, Q53, Q54	Tomo 15 · 15.9 (Pág. 28)
6.02.2.008	Heridas de párpados	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
BLOQUE 4: PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA					
6.02.1.001	Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68, Q69, Q70, Q71, Q72	Tomo 15 · 15.15 (Pág. 50)
6.02.1.010	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.020	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Derivar** · Seg: **Control**	GES	Q66, Q67	Tomo 15 · 15.14 (Pág. 45)
6.02.1.022	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.023	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.025	Tumores de conjuntiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.027	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Derivar** · Seg: **Control**	GES	Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64	Tomo 15 · 15.12 (Pág. 39)
6.02.2.009	Parálisis III par + midriasis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 15 · C.21 (Pág. 46)
BLOQUE 5: TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA					
1.01.1.015	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83, Q84	Tomo 01 · 5.1 (Pág. 87)
6.02.1.016	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85, Q86	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.017	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87, Q88, Q89	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.026	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q90	Tomo 15 · C.20 (Pág. 44)
6.02.1.028	Tumores de párpado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73, Q74	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.030	Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 15 · 15.17 (Pág. 56)
6.02.2.001	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q75	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.002	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76, Q77	Tomo 15 · 15.16 (Pág. 54)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Oftalmología · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

TOMO 15 · PARTE B: ORDEN NUMÉRICO

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.01.1.015	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83, Q84	Tomo 01 · 5.1 (Pág. 87)
2.01.1.005	Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35, Q36	Tomo 15 · 15.8 (Pág. 26)
2.01.1.097	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3, Q4, Q5, Q6	Tomo 15 · 15.1 (Pág. 5)
6.02.1.001	Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68, Q69, Q70, Q71, Q72	Tomo 15 · 15.15 (Pág. 50)
6.02.1.002	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12, Q24, Q25, Q26, Q27, Q31, Q32	Tomo 15 · 15.3 (Pág. 11)
6.02.1.003	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47	Tomo 15 · 15.10 (Pág. 33)
6.02.1.004	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q13	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.005	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q9	Tomo 15 · 15.2 (Pág. 9)
6.02.1.006	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q16	Tomo 15 · 15.4 (Pág. 13)
6.02.1.007	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Derivar**	—	Q10	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.008	Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q11	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.009	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.010	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q65	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.011	Estrabismo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 15 · C.23 (Pág. 50)
6.02.1.012	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q28, Q29	Tomo 15 · C.24 (Pág. 52)
6.02.1.013	Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q33, Q34	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.014	Hifema	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.015	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.016	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q85, Q86	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.017	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87, Q88, Q89	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.018	Obstrucción completa de la vía lacrimal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.019	Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q15	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.020	Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Derivar** · Seg: **Control**	GES	Q66, Q67	Tomo 15 · 15.14 (Pág. 45)
6.02.1.021	Escleritis y Episcleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21, Q22, Q23	Tomo 15 · 15.5 (Pág. 15)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
6.02.1.022	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q57	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.023	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q58	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.024	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7	Tomo 15 · C.16 (Pág. 36)
6.02.1.025	Tumores de conjuntiva	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.026	Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q90	Tomo 15 · C.20 (Pág. 44)
6.02.1.027	Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES	Dx: **Sospecha** Tx: **Derivar** · Seg: **Control**	GES	Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, Q64	Tomo 15 · 15.12 (Pág. 39)
6.02.1.028	Tumores de párpado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73, Q74	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.029	Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.1.030	Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 15 · 15.17 (Pág. 56)
6.02.1.031	Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q51	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.001	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q75	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.002	Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q76, Q77	Tomo 15 · 15.16 (Pág. 54)
6.02.2.003	Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q48	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.004	Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49, Q50, Q52, Q53, Q54	Tomo 15 · 15.9 (Pág. 28)
6.02.2.005	Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.006	Hemorragia vítrea	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.007	Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.008	Heridas de párpados	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)
6.02.2.009	Parálisis III par + midriasis	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q56	Tomo 15 · C.21 (Pág. 46)
6.02.2.010	Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 15 · Oftalmología (Pág. 8)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

PREGUNTA 1 6.02.1.011

1. **Un niño de 2 meses presenta estrabismo bilateral, fluctuante y que aparece con bastante frecuencia. Ha incrementado bien de peso y no tiene otros síntomas. Se realiza examen ocular, que muestra rojo pupilar presente bilateral, sin defectos y movilidad ocular sin alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar fondo de ojo
B) Derivar a oftalmólogo pediátrico
C) Indicar parches oculares intermitentes
D) Solicitar TAC de órbitas
E) Mantener el control habitual del niño sano

PREGUNTA 2 6.02.1.029

2. **Una niña de 2 años comienza con estrabismo, con desviación hacia lateral del ojo izquierdo. A la inspección ocular, se observa leucocoria izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Retinoblastoma
B) Glaucoma congénito
C) Catarata congénita
D) Retinopatía del prematuro
E) Tumor de órbita

PREGUNTA 3 2.01.1.097

3. **Un hombre de 62 años consulta en el servicio de urgencias por dolor ocular derecho intenso de inicio brusco hace 3 horas, asociado a náuseas y vómitos. Refiere ver halos de colores alrededor de las luces. Al examen: inyección periquerática severa, córnea con pérdida difusa del brillo ("en vidrio esmerilado"), pupila derecha en midriasis media fija no reactiva y consistencia ocular pétrea a la palpación digital. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata más adecuada?**

A) Uveítis anterior aguda; indicar colirio de atropina al 1% y derivar a policlínico
B) Conjuntivitis hiperaguda; indicar ceftriaxona intramuscular y lavado con suero
C) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; iniciar manitol endovenoso, acetazolamida oral y timolol tópico, y derivar de urgencia
D) Queratitis bacteriana severa; indicar colirios reforzados de vancomicina y oclusión
E) Desprendimiento de retina; reposo en cama en posición decúbito supino y derivar vía GES

PREGUNTA 4 2.01.1.097

4. **Una mujer de 24 años consulta por ojo izquierdo rojo de 24 horas de evolución, asociado a sensación de arenilla y prurito leve. Al examen: agudeza visual 20/20 en ambos ojos, inyección conjuntival periférica difusa con vasos móviles que respeta el limbo esclerocorneal, secreción mucosa escasa, pupilas isocóricas y reactivas, córnea transparente. ¿Cuál es la conducta más adecuada en la atención primaria?**

A) Derivar de urgencia a oftalmología en menos de 2 horas
B) Indicar colirio antibiótico (cloranfenicol al 0.5%), medidas de higiene y control ambulatorio si no mejora
C) Indicar colirio de dexametasona al 0.1% cada 4 horas por 7 días
D) Solicitar tomografía computarizada de órbita y encéfalo
E) Realizar tonometría aplanática y prueba de provocación con midriáticos

PREGUNTA 5 2.01.1.097

5. **Un paciente de 45 años con antecedente de espondiloartritis seronegativa consulta por dolor sordo en ojo izquierdo, fotofobia intensa y lagrimeo. Al examen se constata inyección periquerática, agudeza visual OI 20/40 y pupila izquierda miótica de 2 mm que responde escasamente a la luz, a diferencia de la derecha que mide 4 mm. La tinción con fluoresceína es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Uveítis anterior aguda
B) Glaucoma agudo de ángulo cerrado
C) Úlcera corneal herpética
D) Conjuntivitis alérgica estacional
E) Epiescleritis simple

PREGUNTA 6 2.01.1.097

6. **Un hombre de 58 años despierta con una mancha roja viva en el sector nasal del ojo derecho. No refiere traumatismo, dolor, pérdida de visión ni secreción ocular. Al examen: hemorragia plana homogénea que oculta los vasos esclerales en la conjuntiva bulbar nasal, agudeza visual 20/20 bilateral, pupilas normales y córnea transparente. Presión arterial: 125/80 mmHg. ¿Cuál es la conducta indicada?**

A) Indicar ácido tranexámico oral y reposo absoluto
B) Tranquilizar al paciente, explicar que se resolverá en 10-14 días y no indicar fármacos tópicos
C) Instilar colirio de fenilefrina para lograr vasoconstricción inmediata
D) Realizar paracentesis conjuntival para evacuar el hematoma
E) Derivar de inmediato para fotocoagulación láser

PREGUNTA 7 6.02.1.024

7. **Paciente de 40 años con ojo rojo, sensación de arenilla, lagrimeo y fotofobia desde hace 3 meses. Usa lentes de contacto hace años. Antecedente de artritis reumatoide. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de ojo seco (queratoconjuntivitis sicca)
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Úlcera corneal por Acanthamoeba
D) Escleritis
E) Glaucoma agudo

PREGUNTA 8 6.02.2.007

8. **Niño con aumento volumen de párpado, eritema, y secreción purulenta, no puede abrir el ojo: a. Celulitis periorbitaria (sin oftalmoplejia, dolor al mover el ojo, proptosis, disminución de la agudeza visual) Según yo salia que no podía abrir el ojo, decía literalmente "dolor al-1hh1-examen oftalmológico, eso se puede ƒasumir como dolor a la oculomotilidad)**

B) celulitis orbitaria
C) Chalazion infectado
C) Control sano habitual
D) Derivar a especialista
E) Hospitalizar

PREGUNTA 9 6.02.1.005

9. **Un paciente de 35 años, con cuadro de ojo rojo asociado a secreción mucopurulenta desde hace un día, por lo cual se le indicó colirio de cloranfenicol cada 8 horas, sin embargo evoluciona posteriormente con aumento del enrojecimiento, edema palpebral y quemosis. El diagnóstico más probable es:**

A) Alergia al cloranfenicol
B) Celulitis orbitaria
C) Obstrucción lacrimal
D) Chalazion
E) Absceso tarsal

PREGUNTA 10 6.02.1.007

10. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Conjuntivitis no infecciosa · 6.02.1.007] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conjuntivitis no infecciosa. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 11 6.02.1.008

11. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Conjuntivitis viral no complicada · 6.02.1.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conjuntivitis viral no complicada. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 12 6.02.1.002

12. **Una niña de 12 años consulta por molestias, secreción y una lesión en el ojo iz- quierdo, que se muestra en la siguiente foto: INSERTAR FOTO ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Amoxicilina
B) Azitromicina
C) Aciclovir
D) Mupirocina
E) Dexametasona

PREGUNTA 13 6.02.1.004

13. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Chalazion · 6.02.1.004] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Chalazion. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 14 6.02.1.009

14. **Una paciente de 60 años está en espera de cirugía, por obstrucción crónica del conducto nasolagrimal, sin embargo presenta cuadro de aumento de volumen en la zona medial del ojo derecho, con dolor, eritema y epifora. La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar antibióticos orales
B) Indicar masajes y compresiones locales
C) Indicar corticoides tópicos
D) Indicar antibióticos en colirios
E) Resolver quirúrgicamente

PREGUNTA 15 6.02.1.019

15. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Orzuelo no complicado · 6.02.1.019] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Orzuelo no complicado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 16 6.02.1.006

16. **Una paciente de 32 años, con antecedentes de asma y rosácea, usuaria de corticoides inhalados, presenta un cuadro de algunos meses de evolución de ojo rojo bilateral, asociado a ardor, epifora y secreción mucosa, que a veces se vuelve purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Glaucoma agudo
B) Blefaritis
C) Uveítis
D) Dacriocistitis
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

PREGUNTA 17 6.02.1.015

17. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Leucoma corneal · 6.02.1.015] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Leucoma corneal. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 6.02.2.010

18. **Una paciente miope, usuaria de lentes de contacto blando, consulta por dolor ocular izquierdo, asociada a epifora. Al examen muestra ojo rojo periquerático en el ojo izquierdo, con lagrimeo y una zona de opacidad corneal de 2,1 mm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Conjuntivitis bacteriana

B) Úlcera corneal

C) Uveítis aguda

D) Glaucoma agudo

E) Blefaritis

BLOQUE 2 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR

PREGUNTA 19 6.02.1.014

19. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hifema · 6.02.1.014] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hifema. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 6.02.2.006

20. **Un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, mal controlado, consulta por pérdida súbita e indolora de la visión del ojo izquierda. Con el ojo izquierdo solo puede contar dedos. Al examen físico no se ven alteraciones externas, pero el rojo pupilar del ojo izquierdo está muy disminuido. El diagnóstico más probable es:**

A) Trombosis de la vena central de la retina

B) Desprendimiento de retina

C) Neuritis óptica

D) Embolia de arteria central de la retina

E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 21 6.02.1.021

21. **Una paciente de 42 años consulta por dolor ocular derecho, asociado a ojo rojo que inició hace 5 horas y se ha vuelto muy intenso. Al examen Fsico, presenta epífora y ojo rojo derecho de 8po central. Como antecedente, 8ene as8gma8smo y es usuaria de lentes de contacto. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

A) Fondo de ojo

B) Tonometría ocular

C) TAC de órbitas

D) Tinción con fluoresceína

E) Gonioscopía

PREGUNTA 22 6.02.1.021

22. **Una mujer de 32 años consulta por enrojecimiento sectorial en el ojo derecho de 3 días de evolución, asociado a sensación leve de arenilla, sin dolor intenso ni baja de visión. Al examen: agudeza visual 20/20 bilateral, inyección vascular roja brillante triangular en el sector temporal de la conjuntiva bulbar. Tras instilar una gota de fenilefrina al 2.5%, la hiperemia vascular desaparece casi por completo a los 10 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Escleritis necrotizante; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa

B) Epiescleritis simple; indicar lubricantes oculares o AINE tópico y tranquilizar a la paciente

C) Glaucoma agudo incipiente; indicar pilocarpina al 2% en colirio

D) Uveítis anterior aguda; solicitar resonancia magnética cerebral

E) Queratitis estromal herpética; iniciar aciclovir endovenoso

PREGUNTA 23 6.02.1.021

23. **Un paciente de 60 años con antecedente de granulomatosis con poliangeítis (Wegener) consulta por dolor ocular lancinante en ojo derecho que le impide dormir y le irradia a la frente. Al examen físico se aprecia una zona nodular sobreelevada de color violáceo oscuro en la esclera superior que no se modifica con la instilación de fenilefrina tópica. ¿Cuál es la complicación más temida si este cuadro no recibe tratamiento sistémico oportuno?**

A) Catarata cortical senil bilateral

B) Necrosis y adelgazamiento escleral con perforación del globo ocular (escleromalacia)

C) Desprendimiento de retina regmatógeno por desgarro gigante

D) Oclusión de la vena central de la retina

E) Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica

PREGUNTA 24 6.02.1.002

24. **Una paciente de 67 años acude a un SAPU por cefalea hemicraneana izquierda intensa de 2 horas de evolución, acompañada de vómitos reiterados y visión borrosa ipsilateral. El médico de turno sospecha migraña con aura o accidente cerebrovascular. Sin embargo, al examen ocular destaca inyección ciliar severa, edema corneal en vidrio deslustrado, pupila izquierda en midriasis media de 5 mm no reactiva a la luz y marcado endurecimiento del globo ocular a la palpación digital comparativa. ¿Cuál es la terapia farmacológica de primera línea más indicada mientras se gestiona su traslado urgente?**

A) Sumatriptán subcutáneo y metoclopramida endovenosa

B) Manitol endovenoso al 20%, acetazolamida oral y timolol tópico

C) Atropina en colirio al 1% y dexametasona subconjuntival

D) Pilocarpina tópica en dosis masivas continuas cada 2 minutos

E) Heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico

PREGUNTA 25 6.02.1.002

25. Tras compensar médicamente con éxito una crisis de glaucoma agudo por cierre angular en el ojo derecho de un paciente de 60 años, reduciéndose la PIO a 16 mmHg, el oftalmólogo planifica el tratamiento definitivo con iridotomía láser YAG. ¿Cuál es la indicación respecto al ojo izquierdo contralateral, que actualmente se encuentra completamente asintomático con PIO de 14 mmHg?

A) Observación clínica anual sin ninguna intervención invasiva
B) Realizar iridotomía periférica con láser YAG profiláctica en el ojo izquierdo
C) Indicar tratamiento de por vida con colirio de atropina profiláctica
D) Indicar pilocarpina tópica diaria únicamente en caso de que aparezca dolor
E) Indicar cirugía de desprendimiento de retina preventiva

PREGUNTA 26 6.02.1.002

26. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está CONTRAINDICADO administrar a un paciente con sospecha o antecedentes de ángulo iridocorneal estrecho sin iridotomía previa?

A) Paracetamol oral
B) Tropicamida en colirio oftálmico
C) Timolol colirio al 0.5%
D) Latanoprost colirio
E) Amoxicilina oral

PREGUNTA 27 6.02.1.002

27. Un hombre de 55 años con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo cerrado consulta a su médico porque leyó en el prospecto de un fármaco que la pilocarpina al 2% en colirio puede provocarle efectos no deseados. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual la pilocarpina ayuda a resolver la crisis de cierre angular?

A) Induce midriasis máxima que relaja el iris hacia el centro de la pupila
B) Inhibe la producción de humor acuoso a nivel de los procesos ciliares
C) Estimula los receptores muscarínicos induciendo miosis, lo que estira y tracciona la raíz del iris alejándola del trabéculo
D) Aumenta el drenaje uveoescleral de la linfa retiniana
E) Produce deshidratación hiperosmolar del cuerpo vítreo

PREGUNTA 28 6.02.1.012

28. Un lactante de 5 meses, con antecedente de haber nacido a las 35 semanas, presenta cambios en el aspecto de sus ojos, sin otros síntomas. Se realiza medición del diámetro corneal, que resulta 14 mm (VN: 10 a 12 mm) y prueba de fluoresceína, con aclaramiento de 5 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Glaucoma congénito
B) Atresia de la vía lagrimal
C) Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
D) Ambliopía
E) Retinopatía del prematuro

PREGUNTA 29 6.02.1.012

29. Un lactante de 5 meses presenta opacidad corneal bilateral, asociado a epifora y au- mento del diámetro corneal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinoblastoma
B) Macrocórnea
C) Glaucoma congénito
D) Atresia lagrimal
E) Catarata congénita

PREGUNTA 30 6.02.2.005

30. Un paciente de 30 años, hipermétrope, consulta por cefalea intensa, en el lado derecho, asociado a náuseas, de intensidad 10/10. Al examen físico se observa ojo rojo profundo en el lado derecho, con pupila en midriasis fija y arreactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma agudo
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Cefalea cluster
D) Celulitis orbitaria
E) Accidente vascular encefálico

PREGUNTA 31 6.02.1.002

31. Un hombre de 58 años, asintomático, acude a chequeo oftalmológico por tener un padre ciego por glaucoma. Su agudeza visual es 20/20 bilateral. En el fondo de ojo se constata una relación excavación/papila de 0.7 en el ojo derecho y 0.65 en el izquierdo, con adelgazamiento del anillo neurorretiniano inferior. La tonometría marca 24 mmHg en ambos ojos y la campimetría computarizada revela un escalón nasal en ojo derecho. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea de elección para este paciente?

A) Pilocarpina colirio al 2% cada 6 horas
B) Latanoprost colirio al 0.005% una vez al día en la noche
C) Acetazolamida oral 250 mg cada 8 horas en forma indefinida
D) Atropina colirio al 1% cada 12 horas
E) Nafazolina colirio cada 8 horas

PREGUNTA 32 6.02.1.002

32. ¿Cuál es la razón principal por la cual el glaucoma crónico de ángulo abierto suele diagnosticarse tardíamente en la práctica clínica ambulatoria?

A) Cursa con dolor ocular intermitente que el paciente confunde con fatiga visual
B) La pérdida del campo visual comienza en la periferia respetando la agudeza visual central hasta fases muy avanzadas
C) Produce opacidad temprana de la córnea que impide la visión del fondo de ojo
D) Se asocia de forma constante a episodios de ojo rojo bilateral evanescente
E) Porque no existen tratamientos médicos capaces de detener su evolución

PREGUNTA 33 6.02.1.013

33. Un paciente de 42 años se realiza una tonometría ocular que informa una presión intraocular de 27 mmHg. Presenta una excavación papilar de 0.7 en el ojo derecho y en la gonioscopía se observa ángulo abierto en todo el contorno del iris. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía diabética
B) Neuritis óptica
C) Glaucoma crónico
D) Coriorretinitis
E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 34 6.02.1.013

34. Una paciente de 50 años se realiza una tonomotría ocular, que muestra una presión intraocular de 28 mmHg en el ojo derecho. La inspección ocular no tiene alteracios. La agudeza visual es 1,0 en ambos ojos y se constata una excavación papilar es de 0,7 a derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Degeneración macular relacionada con la edad
B) Neuropatía óptica
C) Glaucoma crónico
D) Catarata
E) Desprendimiento de retina

PREGUNTA 35 2.01.1.005

35. **Un paciente de 65 años, con antecedentes de asma bronquial en tratamiento crónico con corticoides inhalados y pulsos orales frecuentes de prednisona, consulta por disminución rápida de la agudeza visual en ambos ojos de 6 meses de evolución, que le molesta especialmente a la luz del sol brillante. Al examen físico se aprecia una agudeza visual de 20/80 bilateral y en la oftalmoscopía se observa una opacidad densa y granular situada en el polo posterior del cristalino, justo por delante de la cápsula. ¿Cuál es el tipo de catarata más probablemente presente en este paciente?**

A) Catarata cortical anterior
B) Catarata subcapsular posterior
C) Catarata nuclear dura
D) Catarata traumática en roseta
E) Catarata congénita zonular

PREGUNTA 36 2.01.1.005

36. **¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar de primera elección en la actualidad para el tratamiento de la catarata senil en el sistema de salud chileno?**

A) Extracción intracapsular con crioquinectomía dejando el ojo afáquico
B) Facoemulsificación por ultrasonido con implante de lente intraocular plegable en saco capsular
C) Iridotomía periférica con láser YAG bilateral
D) Trabeculectomía con antimetabolitos
E) Vitrectomía pars plana posterior con intercambio gas-líquido

BLOQUE 3 GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO

PREGUNTA 37 6.02.1.018

37. **Un niño de 4 meses de edad consulta por epifora del ojo izquierdo y eritema, que no ha respondido al uso de antibióticos tópicos. Al examen físico se aprecia edema y aumento de volumen de la zona medial, con borramiento de la hendidura palpebral y reflujo al comprimir el saco lagrimal. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma congénito
B) Conjuntivitis bacteriana
C) Atresia lagrimal congénita
D) Queratitis por Chlamydia trachomatis
E) Dacriocele

PREGUNTA 38 6.02.2.008

38. **[URGENCIA: Heridas de párpados · 6.02.2.008] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Heridas de párpados. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 39 6.02.1.003

39. **Pregunta 171 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Una paciente de 78 años presenta disminución de la visión del ojo derecho, de 4 meses de evolución. Al examen tiene caída de la agudeza visual de dicho ojo, con disminución de la visión del contraste y afectación del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma crónico
B) Catarata
C) Degeneración macular relacionada con la edad
D) Vicio de refracción
E) Atrofia del nervio óptico

PREGUNTA 40 6.02.1.003

40. **Un hombre de 48 años, miope de -7 dioptrías, consulta en urgencias por ver destellos luminosos ("fotopsias") y una lluvia de puntos oscuros flotantes en su ojo izquierdo desde hace 2 días. Hace 6 horas comenzó a notar una sombra oscura fija que le tapa la mitad superior del campo visual. El ojo no está rojo ni duele. La agudeza visual en dicho ojo es 20/25. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica inmediata?**

A) Glaucoma agudo de ángulo cerrado; administrar manitol endovenoso y pilocarpina
B) Desprendimiento de retina regmatógeno con mácula aplicada; indicar reposo absoluto y derivar de urgencia para cirugía GES
C) Oclusión de la arteria central de la retina; realizar masaje ocular digital inmediato
D) Neuritis óptica retrobulbar; iniciar pulsos de metilprednisolona endovenosa
E) Crisis migrañosa con aura retiniana; prescribir paracetamol y reposo en habitación oscura

PREGUNTA 41 6.02.1.003

41. **¿Cuál es la diferencia fisiopatológica fundamental entre el desprendimiento de retina regmatógeno y el desprendimiento de retina traccional?**

A) El regmatógeno requiere una rotura o desgarro retiniano que permite el paso de humor vítreo líquido, mientras que el traccional es producido por membranas fibrovasculares que traccionan mecánicamente la retina sin desgarro
B) El regmatógeno es doloroso y con ojo rojo, mientras que el traccional es indoloro
C) El traccional se opera siempre con láser superficial y el regmatógeno solo con corticoides orales
D) El regmatógeno se produce por acumulación de exudados inflamatorios y el traccional por hipertensión intraocular
E) No existe diferencia; son dos términos sinónimos para la misma patología

PREGUNTA 42 6.02.1.003

42. **Una mujer de 55 años, previamente sana, presenta repentinamente la aparición de múltiples moscas volantes y destellos luminosos en el ojo derecho. Acude a evaluación oftalmológica el mismo día. La oftalmoscopía indirecta con pupila dilatada revela un desgarro retiniano periférico en herradura sin líquido subretiniano (sin desprendimiento aún). ¿Cuál es el tratamiento profiláctico de elección para evitar que desarrolle un desprendimiento de retina?**

A) Vitrectomía pars plana urgente con infusión de aceite de silicona
B) Fotocoagulación con láser de argón alrededor del desgarro
C) Inyección intravítrea de triamcinolona
D) Corticoides orales en dosis de 1 mg/kg/día por 1 mes
E) Observación clínica semanal sin intervención

PREGUNTA 43 6.02.1.003

43. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia con el peor pronóstico visual final en un paciente sometido a cirugía de desprendimiento de retina?

A) Desprendimiento localizado en cuadrantes superiores
B) Compromiso de la mácula con desprendimiento foveal (mácula off) de más de una semana de evolución
C) Edad menor a 40 años
D) Uso previo de lentes de contacto blandos
E) Presencia de miodesopsias antes de la cirugía

PREGUNTA 44 6.02.1.003

44. Un paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, consulta por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho. En su evaluación, tiene agudeza visual 20/20 en el ojo izquierdo y 15/20 en el ojo derecho. Su rojo pupilar demuestra una opacidad central con forma de estrella. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Retinopatía diabética
B) Edema macular
C) Catarata
D) Glaucoma
E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 45 6.02.1.003

45. Lactante de 7 meses cuya madre nota que al iluminar sus ojos con linterna, el ojo derecho refleja luz blanca (leucocoria) en vez del habitual reflejo rojo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Descartar toxoplasmosis ocular: solicitar serología
B) Catarata congénita: derivar urgente a oftalmología
C) Retinoblastoma: derivar urgente a oftalmología
D) Retinopatía del prematuro: si no fue prematuro, tranquilizar
E) Glaucoma congénito: iniciar colirio

PREGUNTA 46 6.02.1.003

46. Paciente con agudeza visual 20/40 bilateral que no mejora con agujero estenopeico. Refracción sin cambios. ¿Cuál es la causa más probable de esta alteración visual?

A) Opacidad de medios (catarata u otra causa no refractiva)
B) Error refractivo no corregido
C) Ambliopía
D) Glaucoma
E) Degeneración macular

PREGUNTA 47 6.02.1.003

47. En el enfrentamiento clínico sistemático de Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 48 6.02.2.003

48. Pérdida de agudeza visual en días, que alcanzaba a contar dedos y tenía defecto pupilar aferente, Entopsias y fotopsias: a. Desprendimiento de retina

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

PREGUNTA 49 6.02.2.004

49. Un hombre de 68 años con antecedentes de tabaquismo y cardiopatía hipertensiva consulta por pérdida total y súbita de la visión en su ojo derecho hace 1 hora mientras desayunaba. No refiere dolor, cefalea ni traumatismo. Al examen el ojo está blanco, la agudeza visual es de bultos a 50 cm y presenta defecto pupilar aferente relativo en ojo derecho. En el fondo de ojo destaca una retina blanquecina edematosa con una mancha rojo cereza a nivel foveal y vasos arteriales filiformes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Desprendimiento de retina regmatógeno total
B) Oclusión de la arteria central de la retina
C) Oclusión de la vena central de la retina
D) Hemorragia vítrea masiva
E) Neuritis óptica isquémica no arterítica

PREGUNTA 50 6.02.2.004

50. Una mujer de 62 años hipertensa consulta por disminución progresiva de la visión en su ojo izquierdo en las últimas 24 horas. Al fondo de ojo se observan hemorragias retinianas masivas en llama en los cuatro cuadrantes, venas tortuosas muy dilatadas y exudados algodonosos. Tres meses después acude a urgencias por dolor ocular insoportable en el mismo ojo y ojo rojo intenso con PIO de 55 mmHg. ¿Qué complicación ha desarrollado?

A) Glaucoma agudo por cierre angular primario
B) Glaucoma neovascular secundario a isquemia retiniana ("glaucoma de los 100 días")
C) Endoftalmitis endógena bacteriana
D) Desprendimiento de retina exudativo
E) Uveítis anterior hipertensiva secundaria a toxoplasmosis

PREGUNTA 51 6.02.1.031

51. [ATENCIÓN PRIMARIA: Vicios de refracción en personas de 65 años o más · 6.02.1.031] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Vicios de refracción en personas de 65 años o más. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 52 6.02.2.004

52. **Un joven de 18 años consulta por dificultad progresiva para ver con nitidez el pizarrón de la universidad, refiriendo que tiene que entrecerrar los ojos para enfocar a la distancia. Al examinarlo de cerca para leer un libro, su visión es perfecta y no refiere molestias. En la tabla de Snellen su agudeza visual de lejos es 20/60 bilateral, la cual mejora de inmediato a 20/20 al mirar a través de un agujero estenopeico. ¿Cuál es el diagnóstico refractivo y el tipo de lente corrector adecuado?**

A) Hipermetropía; corregir con lentes convergentes positivos (+)
B) Miopía; corregir con lentes divergentes negativos (-)
C) Presbicia precoz; corregir con lentes bifocales
D) Astigmatismo irregular; corregir con lentes prismáticos
E) Ambliopía anisometrópica; indicar parche oclusivo

PREGUNTA 53 6.02.2.004

53. **Un lactante de 10 meses es llevado a control por sospecha de estrabismo. Al examen, el oftalmólogo constata una catarata congénita monocular densa en el ojo derecho que ocluye completamente el eje pupilar. ¿Cuál es el principal riesgo a largo plazo si no se opera oportunamente antes del año de vida?**

A) Glaucoma neovascular de ángulo abierto
B) Ambliopía profunda por deprivación sensorial irreversible
C) Desprendimiento de retina traccional
D) Retinoblastoma bilateral secundario
E) Subluxación anterior del cristalino

PREGUNTA 54 6.02.2.004

54. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

BLOQUE 4 PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA

PREGUNTA 55 6.02.1.025

55. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores de conjuntiva · 6.02.1.025] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores de conjuntiva. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 6.02.2.009

56. **[URGENCIA: Parálisis III par + midriasis · 6.02.2.009] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Parálisis III par + midriasis. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 57 6.02.1.022

57. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Retinopatía del prematuro · 6.02.1.022] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retinopatía del prematuro. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 58 6.02.1.023

58. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Retinopatía diabética · 6.02.1.023] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Retinopatía diabética. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 59 6.02.1.027

59. **Un paciente de 52 años es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 en un chequeo preventivo de salud. Se encuentra completamente asintomático desde el punto de vista visual. ¿Cuál es la indicación correcta respecto al tamizaje oftalmológico según las guías clínicas del MINSAL y la garantía GES N° 23?**

A) Realizar fondo de ojo con pupila dilatada al momento del diagnóstico y luego anualmente

B) Esperar 5 años desde el diagnóstico para realizar el primer fondo de ojo

C) Solicitar fondo de ojo únicamente si la hemoglobina glicosilada supera el 8.0%

D) Realizar fondo de ojo solo cuando el paciente refiera disminución de agudeza visual

E) Derivar a cirugía preventiva de catarata bilateral de inmediato

PREGUNTA 60 6.02.1.027

60. **¿Cuál es la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en los pacientes con diabetes mellitus?**

A) Glaucoma neovascular de ángulo cerrado

B) Edema macular diabético

C) Desprendimiento de retina regmatógeno

D) Oclusión de la arteria central de la retina

E) Neuritis óptica desmielinizante

PREGUNTA 61 6.02.1.027

61. **Un hombre de 60 años con diabetes mellitus mal controlada consulta por pérdida súbita, indolora y masiva de la visión en su ojo derecho ocurrida esta mañana. Refiere que ve todo "rojo oscuro y con telarañas flotantes". Al examen físico el ojo no está rojo ni duele, no hay reflejo rojo pupilar en el ojo derecho y a la oftalmoscopía es imposible visualizar los detalles de la retina debido a una opacidad hemática en la cavidad posterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorragia vítrea secundaria a retinopatía diabética proliferativa

B) Glaucoma agudo fulminante

C) Catarata hipermadura morgagniana

D) Endoftalmitis micótica endógena

E) Queratitis dendrítica extensa

PREGUNTA 62 6.02.1.027

62. **¿Cuál es el mecanismo de acción principal y el objetivo terapéutico de la panfotocoagulación con láser de argón en la retinopatía diabética proliferativa?**

A) Coagular directamente la arteria central de la retina para disminuir la presión vascular

B) Destruir zonas de retina periférica isquémica para reducir la producción de factores angiogénicos (VEGF) y lograr la regresión de los neovasos

C) Eliminar físicamente los exudados duros lipídicos de la fóvea

D) Aumentar la presión intraocular para aplanar la retina desprendida

E) Reemplazar el humor vítreo por humor acuoso artificial

PREGUNTA 63 6.02.1.027

63. **Un paciente de 63 años con hipertensión arterial crónica acude a control. En el fondo de ojo se observan arteriolas retinianas estrechadas de aspecto brillante y cobrizo, y a nivel de los cruces arteriovenosos se aprecia un afilamiento y ocultamiento del trayecto de las vénulas por debajo de las arteriolas (signo de Gunn positivo), sin hemorragias ni exudados. ¿A qué grado de la clasificación de Keith-Wagener-Barker corresponde este hallazgo?**

A) Grado I

B) Grado II

C) Grado III

D) Grado IV

E) Retinopatía proliferativa grado B

PREGUNTA 64 6.02.1.027

64. **Un hombre de 45 años ingresa al servicio de urgencias con presión arterial de 230/140 mmHg, cefalea holocraneana y confusión. Al fondo de ojo se evidencia borramiento de los bordes de ambas papilas ópticas con sobreelevación papilar, exudados algodonosos y hemorragias retinianas en llama. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta respecto al manejo de su presión arterial?**

A) Administrar nifedipino sublingual para descender la presión arterial a menos de 120/80 mmHg en 15 minutos

B) Hospitalizar en cuidados intensivos e iniciar labetalol endovenoso reduciendo la presión arterial media en un 20 a 25% en las primeras horas

C) Indicar enalapril oral 20 mg y enviar a domicilio con control en 48 horas

D) Realizar punción lumbar urgente antes de iniciar cualquier tratamiento hipotensor

E) Indicar diuréticos de asa orales en dosis única y analgesia

PREGUNTA 65 6.02.1.010

65. **Un paciente de 77 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, presenta visión distorsionada de las letras y refiere que las líneas se ven onduladas. Actualmente tiene un escotoma central. Se hace un fondo de ojo, que se muestra a continuación: Foto 14 (https://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/01/25/medicina/1169733277 El diagnóstico más probable es:**

A) Desprendimiento de retina

B) Retinopatía hipertensiva

C) Trombosis de la vena central de la retina

D) Catarata

E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 66 6.02.1.020

66. Una mujer de 72 años consulta porque nota que los marcos de las puertas y los azulejos de su baño se ven curvados y distorsionados al mirar con su ojo izquierdo. Al examen con la cartilla de cuadrícula de Amsler describe que las líneas rectas de la rejilla se ondulan hacia el centro de la mirada. El fondo de ojo revela drusas confluentes y una pequeña hemorragia subretiniana paramacular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la terapia de primera línea indicada?

A) Desprendimiento de retina regmatógeno; fotocoagulación láser periférica
B) Degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda; inyecciones intravítreas de anti-VEGF
C) Retinopatía hipertensiva grado IV; nitroprusiato endovenoso
D) Neuritis óptica isquémica anterior; corticoides sistémicos
E) Glaucoma crónico simple; colirio de latanoprost nocturno

PREGUNTA 67 6.02.1.020

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la pérdida visual producida por la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es CORRECTA?

A) Conduce a una pérdida concéntrica del campo visual periférico respetando la fóvea hasta el final
B) Causa un escotoma central que impide la lectura y reconocimiento de rostros, pero preserva la visión periférica de orientación
C) Produce ceguera total completa de ambos ojos impidiendo incluso la deambulación del paciente
D) Afecta de forma exclusiva a pacientes jóvenes miopes menores de 40 años
E) Cursa con dolor ocular severo y midriasis media fija arreactiva

PREGUNTA 68 6.02.1.001

68. Un paciente de 18 años presenta agudeza visual de 1 en el ojo izquierdo y de 0,6 en el ojo derecho, que mejora a 0,8, al mirar por un agujero estenopeico. No presenta do- lor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Glaucoma
B) Estrabismo
C) Vicio de refracción
D) Catarata
E) Coriorretinitis

PREGUNTA 69 6.02.1.001

69. Un obrero de la construcción acude a un centro de urgencias tras recibir el impacto de un clavo en el ojo izquierdo. Al examen físico el paciente se encuentra muy quejumbroso, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de bultos a 30 cm, la pupila está desfigurada en forma de pera apuntando hacia la hora 2 y se observa una cámara anterior muy plana con salida de un filamento negruzco a través de una incisión en la córnea. ¿Cuál de las siguientes conductas representa una ACCIÓN ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA en este paciente?

A) Instalar una concha o protector rígido fenestrado plástico fijado con tela adhesiva
B) Administrar analgesia y antieméticos por vía endovenosa
C) Realizar tonometría aplanática para cuantificar el grado de hipotonía ocular
D) Indicar ayuno absoluto y solicitar evaluación urgente por oftalmología
E) Administrar vacuna antitetánica si no tiene dosis de refuerzo reciente

PREGUNTA 70 6.02.1.001

70. Un paciente de 26 años recibe un golpe de puño directo en el ojo derecho durante una riña. Al examen en el box se aprecia un hipema traumático que ocupa el tercio inferior de la cámara anterior (Grado I), agudeza visual 20/40 y no hay signos de globo abierto. ¿Cuál es la indicación de manejo ambulatorio o en sala más adecuada y la complicación principal que se busca prevenir en los primeros días?

A) Reposo en cama con cabecera a 45 grados, protector rígido y evitar aspirina/AINEs; prevenir resangrado a las 48-72 horas
B) Reposo en decúbito prono estricto con la cara hacia abajo; prevenir catarata traumática
C) Indicar aspirina 500 mg cada 8 horas para licuar el coágulo; prevenir la trombosis de arteria central
D) Realizar paracentesis corneal inmediata con aguja fina en el box de urgencias
E) Instilar colirio de pilocarpina cada 15 minutos; prevenir la ciclоplejía traumática

PREGUNTA 71 6.02.1.001

71. Un tornero mecánico ingresa a urgencias tras sentir el impacto de una partícula de acero a alta velocidad en su ojo izquierdo mientras utilizaba una pulidora sin gafas protectoras. La agudeza visual es 20/30, se observa una mínima hemorragia subconjuntival temporal pero no se aprecian cuerpos extraños en la córnea ni fondos de saco. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección que debe solicitarse para descartar un cuerpo extraño intraocular radiopaco?

A) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con cortes finos
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbita sin contraste con cortes finos de 1 mm
C) Radiografía simple de cráneo anteroposterior
D) Ecografía ocular modo A con sonda de alta frecuencia
E) Gammagrafía ósea facial

PREGUNTA 72 6.02.1.001

72. ¿Cuál es el objetivo principal de administrar antieméticos parenterales (como ondansetrón endovenoso) en un paciente con sospecha de estallido o ruptura de globo ocular?

A) Prevenir la absorción sistémica de las toxinas de la flora conjuntival
B) Evitar las náuseas y el vómito, ya que la maniobra de Valsalva asociada eleva bruscamente la presión intraocular y puede expulsar el contenido intraocular
C) Inducir miosis pupilar farmacológica para sellar la herida
D) Facilitar la penetración de los colirios a través de la barrera hematoencefálica
E) Disminuir la producción de humor acuoso por los procesos ciliares

PREGUNTA 73 6.02.1.028

73. Adulto que consulta por lesión pruriginosa de 3 meses en párpado inferior que aumentó de volumen. ¿Diagnóstico más probable?

A) Chalazión crónico
B) Orzuelo interno
C) Carcinoma basocelular
D) Carcinoma espinocelular
E) Melanoma ocular

PREGUNTA 74 6.02.1.028

74. Un paciente de 70 años consulta por aparición de una lesión pruriginosa en el párpado inferior izquierdo, que comenzó como un pequeño nódulo hace un año y que ha crecido al tamaño que se observa en la siguiente imagen (Fuente: https://hospitaluvrocio.es/): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Orzuelo
B) Chalazión
C) Melanoma
D) Carcinoma basocelular
E) Conjuntivitis bacteriana crónica

PREGUNTA 75 6.02.2.001

75. Un paciente consulta en el servicio de urgencia, dado que hace 20 minutos le saltó una solución de soda cáustica en la cara, la que entró a los ojos, presentando intenso dolor y dificultades para ver. Al examen físico tiene ojo rojo profundo, córneas opacas y con el ojo derecho solo es capaz de contar dedos, mientras que con el ojo izquierdo tiene agudeza visual 20/80. La conducta más adecuada es:

A) Ungüento antibiótico y parche ocular
B) Lavado con suero fisiológico abundante por 30 minutos
C) Hielo local
D) Corticoides tópicos
E) Analgésicos

PREGUNTA 76 6.02.2.002

76. Un trabajador de aseo sufre salpicadura accidental de soda cáustica líquida en ambos ojos. Es llevado de inmediato al centro de salud familiar más cercano. ¿Cuál es la primera medida que debe realizar el personal de salud al recibir al paciente en el establecimiento?

A) Evaluar y registrar la agudeza visual con la tabla de Snellen
B) Instilar colirio de ácido acético diluido para neutralizar químicamente el álcali
C) Iniciar irrigación ocular continua profusa con suero fisiológico o agua corriente de forma inmediata
D) Aplicar ungüento oftálmico con corticoides y ocluir con parche estéril
E) Llamar a la ambulancia y esperar la llegada del médico oftalmólogo sin tocar los ojos

PREGUNTA 77 6.02.2.002

77. ¿Por qué las quemaduras oculares provocadas por álcalis (como la cal, amoníaco o soda cáustica) revisten una gravedad mucho mayor que las provocadas por ácidos fuertes?

A) Porque los ácidos producen necrosis por coagulación que forma una barrera proteica protectora limitando su penetración, mientras que los álcalis producen necrosis por licuefacción con saponificación que favorece la penetración profunda continua
B) Porque los álcalis se evaporan instantáneamente destruyendo el cristalino por calor seco
C) Porque los ácidos tienen un pH neutro que no interactúa con las membranas celulares
D) Porque los álcalis provocan vasoconstricción retiniana mediada por receptores adrenérgicos
E) Porque las quemaduras por ácidos siempre se resuelven con lágrimas artificiales

PREGUNTA 78 6.02.1.030

78. Un paciente de 30 años, con antecedente de espondilitis anquilosante consulta por ojo rojo izquierdo con dolor, desde hace 24 horas, asociado a disminución de la agudeza visual. Hace 2 años presentó un episodio similar autolimitado, por el que no había consultado. Al examen físico, se muestra lo siguiente: FOTO (Ojo examinado con la luz de hendidura que muestra discoria).

A) Uveítis anterior
B) Catarata
C) Disgenesia pupilar
D) Endoftalmitis
E) Hemorragia vítrea

PREGUNTA 79 6.02.1.030

79. Un escolar de 9 años es evaluado en urgencias por edema y eritema palpebral izquierdo severo tras un cuadro catarral de una semana. Al examen físico presenta fiebre de 38.8 °C. La apertura palpebral espontánea está dificultada por el edema, pero al separar manualmente los párpados se constata que los movimientos oculares están completamente conservados y son indoloros, no hay proptosis y la agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Celulitis orbitaria postseptal; hospitalizar para drenaje quirúrgico inmediato por orbitotomía
B) Celulitis preseptal; iniciar tratamiento antibiótico oral ambulatorio con amoxicilina-ácido clavulánico y control en 24 horas
C) Trombosis del seno cavernoso; iniciar heparina endovenosa y trombolisis
D) Pseudotumor orbitario inflamatorio; indicar corticoides orales en megadosis
E) Conjuntivitis alérgica primaveral; prescribir colirio de antihistamínicos

PREGUNTA 80 6.02.1.030

80. Una niña de 6 años hospitalizada por celulitis orbitaria derecha secundaria a sinusitis etmoidal presenta súbitamente cefalea intensa, náuseas, temperatura de 39.5 °C y comienza con hinchazón, enrojecimiento y proptosis marcada en el ojo izquierdo contralateral. Al examen neurológico se constata midriasis arreactiva bilateral y ptosis bilateral con imposibilidad total para mover ambos ojos en cualquier dirección (oftalmoplejía bilateral completa), con pérdida de sensibilidad en la frente. ¿Cuál es la complicación intracraneana más probable?

A) Meningitis bacteriana aguda por neumococo sin foco trombótico
B) Trombosis séptica del seno cavernoso
C) Absceso epidural frontal contralateral aislado
D) Glaucoma agudo bilateral sincronizado
E) Encefalitis por virus herpes simple tipo 1

PREGUNTA 81 6.02.1.030

81. ¿Cuál es el estudio de imagen de primera línea indicado para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión anatómica y pesquisar complicaciones quirúrgicas ante la sospecha clínica fundada de celulitis orbitaria?

A) Radiografía de senos paranasales en proyecciones de Waters y Caldwell
B) Tomografía computarizada (TAC) de órbitas, senos paranasales y cerebro con contraste endovenoso
C) Ecografía ocular modo B transpalpebral
D) Resonancia magnética nuclear sin contraste
E) Gammagrafía con galio-67

PREGUNTA 82 6.02.1.030

82. ¿Cuál es el esquema antimicrobiano empírico endovenoso de primera línea más recomendado para el tratamiento intrahospitalario de la celulitis orbitaria bacteriana en pediatría?

A) Amoxicilina oral en suspensión cada 8 horas
B) Ceftriaxona endovenosa combinada con vancomicina (o clindamicina)
C) Ciprofloxacino en colirio tópico exclusivo
D) Aciclovir endovenoso en monoterapia
E) Gentamicina intramuscular en dosis única

PREGUNTA 83 1.01.1.015

83. **Una mujer de 29 años previamente sana consulta por disminución de la visión en su ojo izquierdo de 48 horas de evolución, acompañada de dolor en la órbita que se intensifica al mover los ojos. Al examen se constata agudeza visual de 20/70 en ojo izquierdo y 20/20 en ojo derecho. En la prueba de la linterna oscilante, al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se contraen intensamente, pero al pasar el foco de luz al ojo izquierdo ambas pupilas se dilatan de forma paradójica. El fondo de ojo muestra papilas de bordes netos y retina transparente sin anomalías. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para evaluar la etiología y el pronóstico de esta paciente?**

A) Tomografía computarizada de encéfalo sin contraste
B) Resonancia magnética de encéfalo y órbitas con gadolinio
C) Punción lumbar urgente con manometría de apertura
D) Potenciales evocados somatosensoriales periféricos
E) Biopsia de la arteria temporal superficial

PREGUNTA 84 1.01.1.015

84. **Un hombre de 38 años consulta por cefaleas matutinas pulsátiles que aumentan con la tos desde hace dos semanas y episodios breves de oscurecimiento de la visión de 2 a 3 segundos de duración al ponerse de pie. Al examen su agudeza visual es 20/20 en ambos ojos, las pupilas son isocóricas y fotorreactivas normales sin DPAR, pero al fondo de ojo se evidencia borramiento completo de los bordes papilares de forma bilateral, con hiperemia y elevación de ambas cabezas del nervio óptico. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de prioridad obligatoria?**

A) Realizar punción lumbar en el box para medir la presión de apertura de inmediato
B) Solicitar neuroimagen urgente (TAC o RM de cerebro) para descartar un proceso expansivo intracraneano antes de cualquier otra intervención
C) Iniciar colirio de timolol al 0.5% cada 12 horas
D) Indicar tratamiento con acetazolamida oral y enviar a control ambulatorio
E) Prescribir paracetamol y lentes de descanso para la astenopía

PREGUNTA 85 6.02.1.016

85. **Una paciente de 26 años, con antecedente de esclerosis múltiple consulta por disminución de la agudeza visual derecha, de 2 días de evolución, asociado a leve dolor retroocular derecho, que aumenta con los movimientos. Al examen físico se aprecia rojo pupilar y movimientos normales, escape pupilar, con defecto pupilar aferente en el ojo derecho y presencia de un escotoma derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probale?**

A) Desprendimiento de retina
B) Trombosis de la vena central de la retina
C) Trombosis de arteria central de la retina
D) Neuritis óptica
E) Absceso orbitario

PREGUNTA 86 6.02.1.016

86. **Una paciente, con antecedente de esclerosis múltiple, consulta por dolor ocular derecho, de 2 días de evolución, a lo que se le ha agregado visión borrosa. Tiene agudeza visual de 0,9 en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo, que no cambia al mirar por un agujero estenopeico. Además se constata que en el ojo derecho está muy afectada la visión de colores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Discromatopsia
B) Retinitis pigmentosa
C) Coriorretinitis
D) Desprendimiento de retina
E) Neuritis óptica

PREGUNTA 87 6.02.1.017

87. **Un paciente de 65 años, con antecedente de revascularización miocárdica hace un año y cirugía de cataratas, consulta porque hace algunas horas dejó de ver su pie derecho. No ha presentado otros síntomas. Al examen físico se aprecia oculomotilidad normal, inspección normal y defecto pupilar aferente relativo en el ojo derecho. La campimetría muestra pérdida del campo visual inferior del ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neuritis óptica
B) Degeneración macular relacionada con la edad
C) Accidente vascular encefálico occipital
D) Edema macular
E) Neuropatía óptica isquémica

PREGUNTA 88 6.02.1.017

88. **Un paciente de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus 8po 2 y revascularización coronaria hace 3 años, consulta porque hace pocas horas notó que, de forma súbita, dejó de ver su pierna derecha con el ojo derecho. Al examen Fsico presenta inspección ocular normal, agudeza visual 20/30 en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, pupilas isocóricas con defecto pupilar aferente rela8vo, y en la campimetría por confrontación se observa hemianopsia inferior del ojo derecho. El diagnós8co más probable es:**

A) Neuri2s óp2ca isquémica
B) Infarto del lóbulo occipital
C) Desprendimiento de re2na
D) Glaucoma
E) Degeneración macular relacionada con la edad

PREGUNTA 89 6.02.1.017

89. **Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:**

A) Glaucoma agudo
B) Glaucoma crónico terminal
C) Neuritis óptica
D) Neuropatía óptica isquémica
E) Desprendimiento de retina

PREGUNTA 90 6.02.1.026

90. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Tumores de la vía óptica · 6.02.1.026] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Tumores de la vía óptica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 **Respuesta: E** Estrabismo

6.02.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 38). Evalúa el manejo clínico de Estrabismo según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 2 **Respuesta: A** Tumores endoculares (retinoblastoma y otros)

6.02.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 156). Evalúa el manejo clínico de Tumores endoculares (retinoblastoma y otros) según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 3 **Respuesta: C**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

El cuadro clínico con cefalea ocular lancinante, náuseas, halos de colores, midriasis media fija, edema corneal en vidrio deslustrado y ojo pétreo a la palpación es patognomónico de un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado (cierre angular con PIO típicamente > 50-70 mmHg). Es una emergencia oftalmológica absoluta que requiere inicio inmediato de hipotensores oculares sistémicos y tópicos (manitol EV, acetazolamida oral, betabloqueador tópico como timolol) y derivación urgente para iridotomía láser. La atropina (A) está contraindicada porque dilata más la pupila y agrava el bloqueo. Perla. Midriasis media fija más dolor y ojo pétreo es siempre glaucoma agudo.

PREGUNTA 4 **Respuesta: B**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

Se trata de un cuadro clásico de Ojo Rojo Superficial (conjuntivitis bacteriana o viral incipiente) sin signos de alarma: agudeza visual normal, inyección puramente periférica que respeta el limbo, pupilas normales y córnea transparente. La conducta correcta en APS es el manejo sintomático e higiénico con colirio antibiótico de amplio espectro (cloranfenicol tópico) y educación. Los corticoides (C) están contraindicados en APS sin lámpara de hendidura. No requiere derivación urgente (A) ni imágenes (D). Perla. Ojo rojo sin dolor, sin baja de visión y con pupilas normales se maneja en APS sin derivación.

PREGUNTA 5 **Respuesta: A**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

La presencia de ojo rojo profundo (inyección ciliar/periquerática), dolor ocular, fotofobia, miosis hiporreactiva unilateral y antecedente de enfermedad reumatológica (espondiloartritis asociada a HLA-B27) es la presentación arquetípica de una Uveítis Anterior Aguda (iridociclitis). La miosis se produce por espasmo del esfínter pupilar y del músculo ciliar debido a la inflamación intraocular. El glaucoma agudo (B) cursa con midriasis media fija, no miosis. La queratitis (C) tendría tinción positiva con fluoresceína. Trampa. Confundir la miosis de la uveítis con la midriasis media del glaucoma agudo es un error que invierte el tratamiento.

PREGUNTA 6 **Respuesta: B**

2.01.1.097 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

El cuadro corresponde a un Hiposfagma o hemorragia subconjuntival espontánea. Es una patología benigna y autolimitada, secundaria a la rotura de un capilar conjuntival frágil (frecuente tras tos, estornudo o maniobra de Valsalva nocturna). Dado que no hay dolor, la visión es normal y los reflejos pupilares están indemnes, la conducta es netamente expectante: educación, tranquilidad y control tensional si procede. Se reabsorbe espontáneamente en 1 a 2 semanas. No requiere gotas (B). Trampa. Indicar colirios antibióticos o hemostáticos en el hiposfagma es una conducta incorrecta que medicaliza un cuadro benigno.

PREGUNTA 7 **Respuesta: A**

6.02.1.024 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

Síntomas crónicos de ojo seco (arenilla, lagrimeo reflejo, fotofobia) + artritis reumatoide (síndrome de Sjögren secundario) = queratoconjuntivitis sicca. Tratamiento: lágrimas artificiales.

PREGUNTA 8 **Respuesta: A**

Enfrentamiento Clínico del Ojo Rojo: Superficial vs Profundo

6.02.2.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 1). Evalúa el manejo clínico de Herida penetrante o perforante ocular según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

6.02.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Es una conjuntivitis bacteriana, que se complicó con una celulitis orbitaria o postseptal (por la quemosis). La alergia al CAF suele presentarse de otra forma y es muy rara.

PREGUNTA 10 **Respuesta: A**

Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

6.02.1.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conjuntivitis no infecciosa" (6.02.1.007), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 11 **Respuesta: A**

Conjuntivitis Infecciosas (Bacterianas, Virales) y Alérgicas

6.02.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conjuntivitis viral no complicada" (6.02.1.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 12 **Respuesta: C**

Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Era un herpes periocular.

PREGUNTA 13 **Respuesta: A**

Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

6.02.1.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Chalazion" (6.02.1.004), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 14 **Respuesta: A**

Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

6.02.1.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una dacriocistitis aguda. Se trata con ATB orales

PREGUNTA 15 **Respuesta: A**

Patología Palpebral: Orzuelo, Chalazión, Blefaritis y Dacriocistitis

6.02.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Orzuelo no complicado" (6.02.1.019), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 16 **Respuesta: E**

6.02.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

La clínica parece una conjuntivitis alérgica (antecedente de asma), pero no estaba en las alternativas. El antecedente de rosácea orienta mucho a blefaritis, sin embargo, falta la descripción del eritema y descamación palpebral y le sobra la secreción mucosa y mucopurulenta. La conjuntivitis bacteriana crónica (mayor a 4 semanas) clásicamente se asocia a otras alteraciones, como la blefaritis, y sí tiene secreción mucosa y purulenta, más el ojo rojo. No se describe el aumento de volumen de la dacriocistitis. Es una pregunta difícil y no queda completamente claro cuál es el diagnóstico, pero dejaremos como correcta la conjuntivitis crónica, por el tiempo de evolución, por el factor de riesgo y por la clínica compatible. Es una pregunta muy difícil.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

6.02.1.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Leucoma corneal" (6.02.1.015), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

6.02.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Queratitis Aguda y Úlcera Corneal Herpética (Prohibición de Corticoides)

Cuadro clásico

BLOQUE 2 SÍNDROME DE OJO ROJO & SUPERFICIE OCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: A** **Hifema**

6.02.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hifema" (6.02.1.014), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 20 **Respuesta: E** **Hemorragia vítrea**

6.02.2.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La pérdida del rojo pupilar orienta mucho a hemorragia vítrea

PREGUNTA 21 **Respuesta: D**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

La sospecha clínica es una queraGGs o una erosión corneal. El uso de lentes de contacto podría ser la causa. Con la Gnción con fluoresceína se pueden ver mejor las úlceras y erosiones corneales. La genioscopía es úGl en la evaluación del glaucoma agudo.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

El blanqueamiento vascular completo tras la instilación de fenilefrina tópica al 2.5% certifica que la dilatación vascular se ubica exclusivamente en el plexo episcleral superficial, lo que define a la Episcleritis Simple. La ausencia de dolor severo y la conservación de la visión apoyan la benignidad del cuadro. La conducta en APS es sintomática (lágrimas artificiales, compresas frías o un AINE tópico) con resolución espontánea en 1 a 2 semanas. La escleritis (A) no se blanquearía y presentaría dolor intenso terebrante. Perla. Ojo rojo sectorial que blanquea con fenilefrina y no duele intensamente es episcleritis.

PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

6.02.1.021 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Escleritis y Epiescleritis: Prueba de Fenilefrina y Enfermedades Reumatológicas

El paciente presenta una escleritis nodular anterior en el contexto de una vasculitis necrotizante sistémica (Granulomatosis con Poliangeítis). La falta de blanqueamiento con fenilefrina confirma la inflamación de la vasculatura escleral profunda. La complicación más grave y temida de la escleritis no tratada es la necrosis y lisis del colágeno escleral, lo que produce adelgazamiento escleral severo (la esclera se vuelve traslúcida y se visualiza la coroides subyacente de color azul oscuro) con eventual perforación ocular y pérdida irrecuperable del ojo (escleromalacia perforante). Requiere tratamiento inmunosupresor sistémico agresivo inmediato. Trampa. Pensar que la escleritis solo causa molestias inflamatorias superficiales sin riesgo estructural del ojo es un error conceptual grave.

PREGUNTA 24 **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

El cuadro corresponde a un Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado, cuya presentación con cefalea y vómitos con frecuencia lleva a errores diagnósticos confundiéndose con migraña o ACV. La presencia de edema corneal, midriasis media fija y ojo pétreo certifica la hipertensión ocular extrema. El manejo farmacológico inicial obligatorio para salvar la visión es la combinación de Manitol EV (agente osmótico que reduce el volumen vítreo), Acetazolamida oral (inhibidor de anhidrasa carbónica que frena la síntesis de humor acuoso) y colirio de Timolol al 0.5%. La atropina (C) dilata la pupila y sería nefasta. La pilocarpina en monoterapia (D) no funciona con presiones tan altas por isquemia del esfínter. Perla. El manitol EV y la acetazolamida son la piedra angular del rescate en el glaucoma agudo.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

La predisposición anatómica al cierre angular (cámara anterior estrecha, hipermetropía, configuración del iris) es simétrica y bilateral en prácticamente todos los pacientes. Un paciente que ha sufrido una crisis de glaucoma agudo en un ojo tiene más de un 50% de probabilidad de presentar un cuadro idéntico en el ojo adelfo en los próximos meses o años si no se interviene. Por esta razón, la norma internacional y de examen establece de forma mandatoria la realización de Iridotomía Periférica Profiláctica con láser YAG en el ojo contralateral asintomático. Trampa. Pensar que el ojo sano no debe tocarse es un error grave: debe protegerse siempre con láser profiláctico.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

La tropicamida es un fármaco anticolinérgico parasimpaticolítico que bloquea los receptores muscarínicos del esfínter pupilar, produciendo midriasis farmacológica activa. En un ojo con ángulo estrecho no operado, la dilatación pupilar aplasta la base del iris contra la malla trabecular periférica, precipitando un bloqueo pupilar completo e hiperpresión intraocular masiva (crisis de glaucoma agudo). Cualquier fármaco midriático o anticolinérgico está terminantemente contraindicado en ángulos estrechos no tratados. Perla. Todo midriático puede desencadenar un glaucoma agudo en ojos anatómicamente predispuestos.

PREGUNTA 27 **Respuesta: C**

6.02.1.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

La pilocarpina es un agonista colinérgico directo que estimula la contracción del músculo esfínter de la pupila, provocando miosis pupilar intensa. Al contraerse el esfínter y achicarse la pupila, el tejido iridiano se estira y adelgaza mecánicamente, tironeando de la raíz del iris hacia el eje central y desimpactándola del ángulo camerular. Esto libera la malla trabecular y restaura el drenaje normal del humor acuoso. No inhibe la síntesis de acuoso (eso lo hace el timolol y la acetazolamida) ni deshidrata el vítreo (eso lo hace el manitol). Perla. La pilocarpina genera miosis y desobstruye físicamente el ángulo.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

6.02.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

Glaucoma Congénito: La epífora, megalocórnea y buftalmos sugieren glaucoma congénito. La prueba de fluoresceína con aclaramiento lento es compatible con dacriocistitis congénita y glaucoma congénito. El valor normal del aclaramiento de fluoresceína es menor a 5 minutos.

PREGUNTA 29 **Respuesta: C**

6.02.1.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

Es un glaucoma congénito clásico.

PREGUNTA 30 **Respuesta: A**

6.02.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Agudo de Ángulo Cerrado: Cefalea Ocular, Ojo Pétreo, Manitol/Acetazolamida

Es un glaucoma agudo clásico.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

El diagnóstico es Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto confirmado por la tríada de hipertensión ocular (> 21 mmHg), daño estructural en la papila óptica (excavación > 0.6 con muesca inferior) y defecto campimétrico concordante (escalón nasal). El tratamiento médico de primera línea avalado por guías internacionales y del MINSAL son los análogos de prostaglandinas tópicos (como latanoprost, bimatoprost o travoprost) administrados en 1 sola dosis nocturna. Tienen la mayor potencia hipotensora con mínimos efectos sistémicos y excelente adherencia. Los diuréticos orales (C) no se usan en tratamientos crónicos por sus efectos adversos metabólicos. La atropina (D) está contraindicada. Perla. Latanoprost nocturno es el fármaco de elección indiscutido en el glaucoma crónico.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

6.02.1.002 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

La naturaleza silente del glaucoma crónico de ángulo abierto radica en su patrón de destrucción axonal: las fibras del nervio óptico que primero se lesionan corresponden a las áreas periféricas de la retina (produciendo escotomas aislados y constricción progresiva concéntrica del campo visual), mientras que el haz papilomacular que provee la visión central de alta resolución permanece intacto hasta las fases terminales. El paciente continúa leyendo la línea de 20/20 en la tabla de Snellen sin advertir que su campo visual se ha reducido a un "tubo estrecho", consultando solo cuando el daño es masivo e irreversible. Trampa. Creer que una agudeza visual de 20/20 descarta glaucoma crónico es el error más frecuente en medicina general.

PREGUNTA 33 **Respuesta: C**

6.02.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

Glaucoma Crónico: Una presión ocular mayor a 20 mmHg se considera elevada. La excavación papilar mayor a 0.3 también sugiere glaucoma crónico o de ángulo abierto. La gonioscopía, que examina el ángulo de drenaje del ojo, suele mostrar un ángulo abierto en este tipo de glaucoma.

PREGUNTA 34 **Respuesta: C**

6.02.1.013 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Glaucoma Crónico de Ángulo Abierto: Excavación Papilar, Presión Intraocular y Análogos de PG

Es un glaucoma crónico clásico, tanto por la PIO mayor a 20, como por la excavación papilar mayor a 0,3.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

2.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

El uso prolongado o repetido de corticosteroides (tanto sistémicos como tópicos) es la causa farmacológica más frecuente y característica de catarata subcapsular posterior. Esta variedad se ubica en el eje óptico nodal posterior, por lo que produce una pérdida visual precoz y marcada que empeora con la miosis pupilar diurna (luz solar directa o lectura). La catarata nuclear (C) se asocia al envejecimiento senil clásico. La traumática (D) es monocular y en roseta. Perla. Paciente usuario crónico de corticoides con baja visual rápida tiene catarata subcapsular posterior.

PREGUNTA 36 **Respuesta: B**

2.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cataratas: Diagnóstico, Indicación Quirúrgica y Facoemulsificación

La técnica estándar de elección a nivel mundial y cubierta por la garantía GES N° 21 en Chile es la Facoemulsificación con Implante de Lente Intraocular (LIO). Mediante incisiones corneales milimétricas (2.2 mm), se realiza capsulorrexis circular anterior y una sonda de ultrasonido fragmenta y aspira el núcleo y la corteza cristaliniana opacificada, conservando íntegra la cápsula posterior para insertar en su interior una lente intraocular artificial plegable que restituye la refracción del ojo. La extracción intracapsular (A) está en desuso por su alta tasa de complicaciones. La iridotomía (C) es para glaucoma agudo. Perla. La técnica estándar de catarata es siempre facoemulsificación con implante de LIO.

BLOQUE 3 GLAUCOMA & PATOLOGÍA DEL CRISTALINO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: C** **Obstrucción completa de la vía lacrimal** 6.02.1.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una atresia lagrimal clásica. No tien buftalmo ni opacidad corneal, como para pensar en glaucoma congénito.

PREGUNTA 38 **Respuesta: A** **Heridas de párpados** 6.02.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Heridas de párpados" como urgencia clínica (6.02.2.008), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

Es una catarata clásica.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

La tríada clásica de fotopsias (tracción vitreorretiniana), miodesopsias agudas (sangrado o condensación vítrea) y defecto de campo visual progresivo en cortina en un paciente con miopía magna (factor de riesgo número uno) e indoloro es patognomónica de Desprendimiento de Retina Regmatógeno. La agudeza visual conservada (20/25) indica que la fóvea aún no se ha desprendido (mácula "on"), lo que constituye una emergencia quirúrgica de horas antes de que el líquido alcance el centro foveal y provoque daño irreversible. Requiere reposo absoluto y derivación quirúrgica urgente vía GES N° 22. Perla. Fotopsias más cortina negra en ojo blanco de paciente miope es desprendimiento de retina.

PREGUNTA 41 **Respuesta: A**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

El desprendimiento de retina regmatógeno exige de manera sine qua non la presencia de una rotura o desgarro en la retina neurosensorial (del griego rhegma), a través del cual el humor vítreo licuado penetra al espacio subretiniano separando la retina del epitelio pigmentario. En cambio, el desprendimiento traccional se origina por la formación de bandas o membranas fibróticas proliferativas en la cavidad vítrea (características de la retinopatía diabética proliferativa o traumatismos penetrantes) que tiran y levantan físicamente la retina hacia el centro del ojo sin que exista una rotura inicial. Trampa. Confundir el mecanismo del desgarro regmatógeno con la tracción proliferativa diabética altera radicalmente la estrategia quirúrgica.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

Cuando se diagnostica una rotura o desgarro retiniano sintomático de forma precoz ANTES de que el vítreo líquido haya levantado la retina (desgarro sin desprendimiento), el tratamiento de elección es la Fotocoagulación con Láser de Argón (o crioterapia). El láser produce una quemadura térmica controlada en 360 grados alrededor de los bordes del desgarro, originando una cicatriz coriorretiniana densa y firme en pocos días que sella el orificio y "suelda" la retina al epitelio pigmentario, evitando de forma altamente efectiva el desarrollo de un desprendimiento de retina completo. Perla. El desgarro precoz se sella con fotocoagulación láser profiláctica ambulatoria.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

El factor pronóstico determinante de la agudeza visual final tras una cirugía de desprendimiento de retina es el estado de la mácula y el tiempo de isquemia foveal. Si la mácula nunca se desprendió (mácula "on"), más del 90% de los pacientes conservan su agudeza visual preoperatoria. En cambio, si la mácula se desprende (mácula "off"), los conos foveales sufren apoptosis y pérdida irreversible de segmentos externos; si el desprendimiento foveal persiste por más de 7 a 10 días, la recuperación de la visión central fina es sumamente pobre aun cuando la retina se reaplique anatómicamente con éxito. Perla. El desprendimiento de mácula prolongado es el mayor predictor de mala agudeza visual final.

PREGUNTA 44 **Respuesta: C**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

Es una catarata clásica por la disminución de la AV y por la alteración del rojo pupilar (la opacidad como estrella es la catarata misma). La RD no tiene síntomas; el edema macular tiene disminución de la AV en pocos días y no altera el rojo pupilar. El glaucoma no afecta la AV, sino el campo visual y no afecta el rojo pupilar. La HV tiene aparición súbita y se pierde el rojo pupilar.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

Leucocoria (reflejo pupilar blanco) en lactante: principal diagnóstico a descartar es CATARATA CONGÉNITA y retinoblastoma. A los 7 meses sin antecedente de prematuridad, catarata congénita es lo más frecuente. Derivación urgente a oftalmología para tratamiento precoz (cirugía antes de los 10 semanas para evitar ambliopía).

PREGUNTA 46 **Respuesta: A**

6.02.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

El agujero estenopeico mejora la AV solo en errores refractivos. Si NO mejora, la causa es una opacidad de medios (catarata, opacidad corneal, vítreo) o patología retinal/neural. En adulto: pensar en catarata.

PREGUNTA 47 **Respuesta: A**

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

6.02.1.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo, la conducta médica prioritaria es: El desprendimiento de retina regmatógeno es INDOLORO y cursa con OJO BLANCO.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Desprendimiento de Retina: Miodesopsias, Fotopsias y Pérdida de Campo

6.02.2.003 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 71). Evalúa el manejo clínico de Desprendimiento de retina según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

6.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La mancha rojo cereza sobre una retina pálida y edematosa, asociada a pérdida súbita e indolora de la visión y defecto pupilar aferente relativo, es el hallazgo patognomónico clásico de la Oclusión de la Arteria Central de la Retina (OACR). La retina neurosensorial se infarta volviéndose opaca y blanca, mientras que la fóvea (que carece de células ganglionares y se nutre directamente de la coroides profunda sana) brilla con su color rojo natural. La oclusión venosa (C) mostraría hemorragias en llamarada generalizadas. El desprendimiento (A) mostraría retina gris levantada y móvil. Perla. Retina pálida más mancha rojo cereza es siempre oclusión de la arteria central de la retina.

PREGUNTA 50 **Respuesta: B**

Oclusión Vascular Retinal: Arteria (Mancha Rojo Cereza) vs Vena Central

6.02.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cuadro inicial corresponde a una Oclusión de la Vena Central de la Retina (OVCR) de tipo isquémico ("imagen en tormenta retiniana"). La falta de perfusión tisular masiva estimula la producción masiva de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el cual difunde hacia el segmento anterior produciendo rubeosis iridis (neovasos en el iris) y neovascularización del ángulo camerular. Estos vasos anómalos forman una membrana fibrovascular que bloquea mecánicamente la malla trabecular, desencadenando una crisis hipertensiva ocular severa, refractaria y muy dolorosa conocida típicamente como Glaucoma Neovascular o "glaucoma de los 100 días" por su aparición característica alrededor de los 3 meses post-trombosis. Perla. Oclusión venosa de la retina más dolor y presión alta a los 3 meses es glaucoma neovascular.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

6.02.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Vicios de refracción en personas de 65 años o más" (6.02.1.031), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La mala visión lejana contrastada con una excelente visión cercana en un paciente joven es la definición clásica de Miopía. En este defecto, los rayos convergen por delante de la retina debido a un exceso de potencia dióptrica corneal o a un aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular. La mejoría inmediata a 20/20 con el agujero estenopeico confirma que la causa es puramente refractiva. La corrección óptica se realiza mediante lentes divergentes, cóncavos o de poder negativo (-), que desplazan el foco hacia atrás sobre la retina. La hipermetropía (A) afectaría la acomodación y lectura cercana. Perla. Miopía = mala visión de lejos corregida con lentes divergentes negativos (-).

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Una opacidad densa del cristalino en los primeros meses de vida bloquea la llegada de estímulos lumínicos a la retina durante la fase crítica de neurogénesis y maduración sináptica visual en la corteza occipital. Esto genera una Ambliopía por Deprivación Sensorial, que constituye la forma más grave, destructiva y difícil de tratar de ambliopía. Si la catarata congénita no se opera en las primeras semanas o meses de vida y no se inicia terapia oclusiva inmediata, la corteza visual correspondiente a ese ojo se atrofia de forma permanente e irreversible, dejando al paciente con ceguera funcional de por vida en ese ojo. Perla. La catarata congénita debe operarse de inmediato para evitar la ambliopía irreversible.

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños

6.02.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Vicios de Refracción, Presbicia y Ambliopía en Niños, la conducta médica prioritaria es: La miopía tiene el ojo largo, ve mal de lejos y se corrige con lentes divergentes cóncavos (-).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

BLOQUE 4 PÉRDIDA SÚBITA DE VISIÓN & RETINA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** **Tumores de conjuntiva** 6.02.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores de conjuntiva" (6.02.1.025), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A** **Parálisis III par + midriasis** 6.02.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Parálisis III par + midriasis" como urgencia clínica (6.02.2.009), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

6.02.1.022 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retinopatía del prematuro" (6.02.1.022), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

6.02.1.023 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Retinopatía diabética" (6.02.1.023), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 59 **Respuesta: A**

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

En la Diabetes Mellitus Tipo 2, la enfermedad suele tener un curso subclínico y asintomático de 5 a 7 años de evolución antes del diagnóstico clínico formal. Por lo tanto, hasta un 20% de los pacientes recién diagnosticados de DM2 ya presentan algún grado de retinopatía diabética al debut. La norma técnica del MINSAL y la ley GES N° 23 establecen que todo paciente con DM2 debe someterse a evaluación de fondo de ojo con pupila dilatada (o retinografía) al momento del diagnóstico, y posteriormente una vez al año de por vida. En cambio, en la DM1 el fondo de ojo se inicia a los 5 años del debut. Perla. En DM2 el fondo de ojo se pide de inmediato al diagnóstico; en DM1 a los 5 años.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

El Edema Macular Diabético (EMD) es la complicación que con mayor frecuencia produce pérdida de la agudeza visual central en pacientes diabéticos. Puede presentarse en cualquier estadio de la retinopatía, incluso en etapas no proliferativas leves o moderadas, debido a la hiperpermeabilidad de los capilares perifoveales con acúmulo de líquido intrarretiniano en la mácula. Su tratamiento de primera línea avalado por la evidencia son los fármacos anti-VEGF intravítreos. La hemorragia vítrea y el desprendimiento traccional causan cegueras más severas, pero son mucho menos frecuentes que el edema macular. Perla. La causa N° 1 de baja visual en diabéticos es el edema macular.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

La pérdida súbita e indolora de la visión con visión de "humo, telarañas o tinte rojizo" y ausencia de visualización del fondo de ojo por pérdida del reflejo rojo en un paciente con diabetes de larga data es la presentación clínica clásica de una Hemorragia Vítrea (hemovítreo). En diabéticos se debe a la rotura espontánea de los neovasos frágiles de la retina en el contexto de una Retinopatía Diabética Proliferativa no tratada. Requiere reposo semisentado, suspensión de antiagregantes si es seguro, ecografía ocular modo B para descartar desprendimiento traccional asociado y eventual vitrectomía pars plana si no se reabsorbe espontáneamente. Perla. Pérdida súbita visual indolora con visión rojiza y fondo de ojo borroso en diabético es hemorragia vítrea.

PREGUNTA 62 **Respuesta: B**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Retinopatía Diabética: No Proliferativa vs Proliferativa y Edema Macular GES

La Panfotocoagulación Retiniana con Láser (PPR) consiste en aplicar cientos o miles de disparos de láser térmico en la retina periférica no funcionante, respetando el polo posterior y la mácula. Al destruir el tejido retiniano periférico hipóxico e isquémico, se reduce drásticamente el consumo metabólico de oxígeno de la retina externa y se apaga la sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Como consecuencia de la caída de los niveles de VEGF, los neovasos anómalos sufren involución y regresión cicatrizal, eliminando el riesgo de hemorragia vítrea catastrófica y desprendimiento traccional. Perla. El láser panretiniano destruye retina isquémica para frenar el VEGF y secar los neovasos.

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

La presencia de cruces arteriovenosos patológicos (como el signo de Gunn de ocultamiento o afilamiento venoso y el signo de Salus de deflexión en S) junto con esclerosis arteriolar (hilos de cobre o plata) sin la presencia de hemorragias retinianas, exudados ni edema de papila define de manera unívoca al Grado II de la clasificación de Keith-Wagener-Barker. El Grado I solo tiene estrechamiento arteriolar sin cruces marcados. El Grado III añade exudados y hemorragias en llama. El Grado IV suma edema de papila. Perla. Cruces arteriovenosos patológicos (Gunn/Salus) sin hemorragias = Grado II.

PREGUNTA 64 **Respuesta: B**

6.02.1.027 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Retinopatía Hipertensiva: Cruces AV, Exudados Algodonosos y Edema Papilar

El paciente presenta una Retinopatía Hipertensiva Grado IV (edema de papila bilateral), lo que diagnostica una Emergencia Hipertensiva (hipertensión maligna/encefalopatía hipertensiva). El manejo requiere ingreso inmediato a UCI/UTI y fármacos endovenosos titulables (como labetalol o nitroprusiato). La regla farmacológica de oro es que la reducción tensional debe ser controlada y gradual, disminuyendo la presión arterial media entre un 20% y un 25% durante las primeras 2 a 4 horas. Bajar la presión bruscamente (especialmente con fármacos incontrolables como nifedipino sublingual, A) colapsa el flujo sanguíneo cerebral y del nervio óptico, pudiendo provocar un infarto cerebral isquémico o ceguera iatrogénica. Trampa. Nifedipino sublingual o descensos bruscos de PA están prohibidos en emergencias hipertensivas.

PREGUNTA 65 **Respuesta: E**

6.02.1.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

Es un DMRE clásica, tanto por la clínica (metamorfopsias y escotoma central), como por el fondo de ojo (aunque se veían exudados y hemorragias maculares y no solo drusas).

PREGUNTA 66 **Respuesta: B**

6.02.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

La metamorfopsia (percepción de líneas rectas como onduladas) con alteración central en la rejilla de Amsler en un paciente senil con hemorragia subretiniana macular y drusas es diagnóstica de Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) en su variante Húmeda o Neovascular. La causa es una membrana neovascular coroidea anómala estimulada por VEGF que sangra bajo la fóvea. La terapia de primera línea de elección que ha revolucionado el pronóstico de esta enfermedad son las inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-VEGF (como ranibizumab o aflibercept), las cuales frenan la proliferación vascular y reabsorben el fluido foveal. Perla. Metamorfopsia en rejilla de Amsler en paciente mayor es degeneración macular húmeda.

PREGUNTA 67 **Respuesta: B**

6.02.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Derivar · Seg: Control GES

Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) y Escotoma Central

La degeneración macular asociada a la edad destruye selectivamente la mácula lútea y la fóvea central, las cuales son responsables de la visión foveal de alta resolución, la agudeza visual fina, la discriminación del color y la capacidad para leer o reconocer detalles faciales. Sin embargo, la retina periférica permanece indemne y funcionante, por lo que el paciente conserva su campo visual periférico (visión de orientación o navegación), lo que le permite caminar sin tropezar y ser autovalente en su desplazamiento. Nunca produce una ceguera total con pérdida de percepción de luz (amaurosis completa). Trampa. Creer que la DMAE deja al paciente completamente ciego de todo el campo visual es un error de concepto.

PREGUNTA 68 **Respuesta: C**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

La mejora de la AV al mirar por un agujero estenopeico es característico de los vi- cios de refracción.

PREGUNTA 69 **Respuesta: C**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

El paciente presenta signos inequívocos de Globo Ocular Abierto (herida penetrante corneal con prolapso o herniación de tejido uveal/iris a través de la brecha y atalamia). En cualquier sospecha de globo abierto, realizar una tonometría (medición de la presión intraocular) está estrictamente contraindicado, ya que el contacto del tonómetro presiona el ojo y provoca la expulsión masiva del contenido intraocular (vítreo y retina), transformando una herida reparable en una pérdida ocular definitiva. Asimismo, están prohibidas las pomadas y los parches compresivos. La protección con concha rígida ósea (A), analgesia/antieméticos EV (B) y ayuno (D) son conductas mandatorias. Perla. En sospecha de herida penetrante ocular está terminantemente prohibido medir la presión o presionar el ojo.

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

El manejo del hipema traumático consiste en reposo absoluto en cama con la cabecera elevada en 30 a 45 grados (para favorecer la sedimentación inferior de los glóbulos rojos por gravedad, liberando el eje pupilar y el trabéculo superior), protección ocular con concha rígida sin compresión, analgesia con paracetamol y colirio ciclopléjico. Están formalmente contraindicados el ácido acetilsalicílico y los AINEs porque alteran la hemostasia plaquetaria. La complicación más temida en los primeros 3 a 5 días es el RESANGRADO secundario a la lisis del coágulo primario, el cual suele ser mucho más extenso y desencadenar hipertensión ocular severa e impregnación hemática de la córnea. Trampa. La aspirina y AINEs están prohibidos en el hipema por riesgo de resangrado masivo.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

El método diagnóstico de elección indiscutido para la detección, localización espacial y evaluación de cuerpos extraños intraoculares (CEIO) es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas sin medio de contraste con cortes axiales y coronales finos (de 1 mm). La Resonancia Magnética (RM) está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA ante la sospecha de cualquier cuerpo extraño metálico o ferromagnético, ya que el potente campo magnético del resonador provocaría el movimiento o tracción violenta del fragmento dentro del ojo, causando laceraciones retinianas masivas, hemorragia vítrea catastrófica y pérdida inmediata del globo ocular. Perla. El TAC de órbita es el examen de elección para cuerpo extraño; la resonancia está prohibida.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

6.02.1.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

Durante el esfuerzo del vómito o las arcadas intensas, se genera una marcada maniobra de Valsalva con aumento abrupto de la presión intratorácica y de la presión venosa central. Esto se transmite instantáneamente al lecho coroideo vascular retrorbitario, provocando un pico masivo de presión intraocular. En un globo ocular con una solución de continuidad de espesor total (ojo abierto), este aumento de presión actúa como un émbolo hidrostático que extruye y expulsa hacia el exterior el iris, el cristalino, el humor vítreo e incluso la retina completa a través de la herida, transformando un ojo con pronóstico reparable en una lesión irrecuperable. Por ello, la analgesia y la antiemesis profiláctica son medidas de rescate de primer orden. Perla. El vómito en ojo abierto expulsa el vítreo: los antieméticos EV son obligatorios.

BLOQUE 5 TRAUMA OCULAR & NEUROFTALMOLOGÍA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: C** **Tumores de párpado**

6.02.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Carcinoma basocelular

PREGUNTA 74 **Respuesta: D** **Tumores de párpado**

6.02.1.028 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Tumores de párpado.

PREGUNTA 75 **Respuesta: B**

6.02.2.001 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

La causticación ocular se maneja con lavado con abundante agua o SF por 30 minutos. No confundir con las perforaciones oculares, que no se debe tocar el ojo ni aplicarle nada, sino solo analgésicos y antibióticos por vía endovenosa y derivación urgente.

PREGUNTA 76 **Respuesta: C**

6.02.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

En cualquier quemadura química ocular, el factor pronóstico determinante primordial de la sobrevida visual es el tiempo transcurrido hasta el inicio de la irrigación. La soda cáustica es un álcali fuerte que penetra activamente hacia las estructuras profundas del ojo en minutos mediante necrosis por licuefacción. El tratamiento debe iniciarse de forma inmediata en el mismo momento del ingreso del paciente, irrigando abundantemente con suero salino fisiológico o agua corriente a chorro durante al menos 20 a 30 minutos. Nunca debe perderse tiempo en tomar agudeza visual (A), llenar registros ni derivar sin lavar. Intentar neutralizar químicamente con ácidos (B) está formalmente contraindicado porque genera una reacción exotérmica con quemadura térmica adicional. Perla. Quemadura química = lavado ocular profuso inmediato antes de cualquier otra acción.

PREGUNTA 77 **Respuesta: A**

6.02.2.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Quemaduras Químicas Oculares: Lavado Ocular Inmediato y Profuso

La diferencia fisiopatológica crucial radica en el tipo de necrosis tisular inducida. Los ácidos desnaturalizan y precipitan las proteínas celulares formando un coágulo o escara firme sobre la superficie corneal que actúa como un escudo o barrera mecánica que impide o retrasa la penetración del químico a planos más profundos. Por el contrario, los álcalis saponifican los lípidos de las membranas celulares, degradan los mucopolisacáridos del estroma corneal y producen necrosis por licuefacción. Esta lisis tisular no crea ninguna barrera de contención, permitiendo que los iones hidroxilo continúen penetrando activamente hacia el estroma profundo, la cámara anterior, el endotelio, el iris y el cristalino en cuestión de pocos minutos. Perla. Los álcalis licúan y penetran profundamente; los ácidos coagulan y se auto-limitan.

PREGUNTA 78 **Respuesta: A**

6.02.1.030 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

Es una uveítis anterior clásica.

PREGUNTA 79 **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

La ausencia total de afectación de las estructuras intraorbitarias (motilidad ocular completamente libre e indolora, ausencia de proptosis y agudeza visual normal 20/20) confirma que el proceso infeccioso inflamatorio se encuentra estrictamente limitado por delante del tabique orbitario, lo que define a una Celulitis Preseptal (o periorbitaria). En pacientes estables y colaboradores, el tratamiento de elección es ambulatorio con antibióticos orales con cobertura frente a estafilococos y estreptococos (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo), indicando a los padres pautas estrictas de alarma y control clínico obligatorio en 24 horas. La celulitis orbitaria (A) tendría oftalmoplejía o proptosis. Perla. Movilidad ocular conservada e indolora descarta celulitis orbitaria y define celulitis preseptal.

PREGUNTA 80 **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

El seno cavernoso es una estructura venosa dural que recibe el drenaje de ambas órbitas a través de las venas oftálmicas y por el cual discurren los pares craneales III, IV, VI y las ramas V1 y V2 del trigémino. La extensión séptica de una celulitis orbitaria hacia el seno cavernoso produce la temible Trombosis del Seno Cavernoso. Sus signos patognomónicos cardinales son: 1) Bilateralización rápida del edema palpebral y proptosis al ojo opuesto (a través de los senos intercavernosos), 2) Oftalmoplejía dolorosa bilateral completa con ptosis (parálisis de pares III, IV y VI), 3) Hipoestesia en el territorio del nervio oftálmico (V1) y maxilar (V2), y 4) Compromiso sistémico grave y alteración de conciencia. Es una emergencia neuroquirúrgica de altísima mortalidad. Perla. La bilateralización de una celulitis orbitaria con oftalmoplejía total es trombosis del seno cavernoso.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

El examen imagenológico estándar de oro y de primera elección mandatorio ante cualquier sospecha de celulitis orbitaria es la Tomografía Computarizada (TAC) de órbitas y senos paranasales con contraste endovenoso, extendida al encéfalo. El TAC permite: 1) Diferenciar fehacientemente la celulitis preseptal de la orbitaria, 2) Identificar la sinusitis paranasal de origen (etmoidal/maxilar), 3) Detectar precozmente colecciones purulentas que requieren drenaje quirúrgico urgente (absceso subperióstico y absceso intraorbitario), y 4) Descartar trombosis del seno cavernoso y empiemas intracraneanos. Las radiografías simples (A) están obsoletas por su baja sensibilidad. Perla. Sospecha de celulitis orbitaria exige TAC de órbita con contraste de urgencia.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B**

6.02.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Celulitis Preseptal vs Orbitaria (Postseptal): Oftalmoplejía, Proptosis y TAC

La celulitis orbitaria es una infección grave que pone en riesgo la visión y la vida, por lo que requiere hospitalización inmediata y antibioticoterapia parenteral de amplio espectro. La microbiología involucra patógenos nasosinusales como Streptococcus pneumoniae (incluyendo cepas con susceptibilidad intermedia a penicilinas), Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus (incluyendo cepas meticilino-resistentes comunitarias SAMR-AC) y anaerobios orofaríngeos. El esquema estándar recomendado consiste en una cefalosporina de 3.ª generación parenteral con excelente penetración ósea y meníngea (Ceftriaxona o Cefotaxima) combinada con Vancomicina (o Clindamicina) para cobertura de SAMR y estreptococos. Los colirios (C) no tienen ninguna utilidad en infecciones orbitarias profundas. Perla. El tratamiento de la celulitis orbitaria es siempre endovenoso y hospitalizado con ceftriaxona más vancomicina.

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

El cuadro corresponde a una Neuritis Óptica Retrobulbar desmielinizante en una mujer joven (pérdida visual monocular, dolor con la motilidad ocular, DPAR positivo y fondo de ojo normal). El examen de elección incuestionable es la Resonancia Magnética (RM) de cerebro y órbitas con contraste de gadolinio y secuencias FLAIR. La RM permite confirmar la inflamación y realce del nervio óptico y, de manera crucial, pesquisar la presencia de lesiones desmielinizantes asintomáticas en la sustancia blanca periventricular o cuerpo calloso, lo que define el riesgo de progresión a Esclerosis Múltiple clínicamente definida (bajo la cobertura del problema GES N° 68). La TAC (A) tiene muy baja resolución para lesiones desmielinizantes. Perla. Paciente joven con neuritis óptica monocular requiere RM cerebral con contraste para descartar esclerosis múltiple.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

1.01.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

El paciente presenta un Papiledema bilateral franco (edema de papila bilateral con agudeza visual conservada y oscurecimientos visuales posturales transitorios), lo que es un signo de alarma mayor de Hipertensión Endocraneana. La conducta médica primordial, obligatoria e impostergable es solicitar una Neuroimagen urgente (TAC o RM de encéfalo) para descartar la presencia de una masa expansiva intracraneana (tumor, hematoma, absceso) o hidrocefalia obstructiva. Está formalmente PROHIBIDO realizar una punción lumbar (A) a ciegas sin neuroimagen previa en un paciente con papiledema, ya que si existe una masa intracraneana la descompresión brusca del líquido cefalorraquídeo precipitará una herniación cerebral amigdalina o transtentorial fatal. Perla. Papiledema bilateral exige neuroimagen urgente para descartar masa cerebral antes de puncionar.

PREGUNTA 85 **Respuesta: D**

6.02.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

Tanto la clínica (amaurosis más defecto pupilar aferente o escape pupilar), como la esclerosis múltiple, orientan a Neuritis óptica. La causa más frecuente es autoinmune.

PREGUNTA 86 **Respuesta: E**

6.02.1.016 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

Es una neuritis óptica tanto por el antecedente de EM, como por la cínica, aunque tenía AV normal y no mencionaban el RFM.

PREGUNTA 87 **Respuesta: E**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

Tiene una amaurosis parcial súbita, lo que sugiere fuertemente una neuropatía óptica isquémica. Por ser la parte inferior del campo visual izquierdo lo afectado, probablemente la lesión se produjo en la parte superior del nervio óptico izquierdo. La neuritis óptica se instala en horas o días, la DMRE demora meses o años, el edema macular demora días y el accidente vascular occipital tiene una hemianopsia contralateral, afectado ambos campos visuales. Finalmente, también podría haber sido un desprendimiento de retina, aunque suele estar precedido por entopsias o fotopsias y avanzar lentamente, como una "caída de telón", "cierre de cortina" o "levantamiento de un muro".

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

Tanto por el inicio súbito, con factores de riesgo cardiovascular, como por el defecto pupilar aferente relativo (DPAR), es una neuropaVa óptica isquémica, con afectación de la zona superior del nervio óptico derecho (inerva la zona superior de la reGna y corresponde a la zona inferior del campo visual). El DPAR se ve también en la neuriGs óptica desmielinizante y en el desprendimiento de reGna extenso o en la oclusión de la arteria central de la reGna.

PREGUNTA 89 **Respuesta: D**

6.02.1.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR (defecto pupilar aferente relativo) sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

6.02.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Neuroftalmología: Neuritis Óptica, Edema de Papila y Defecto Pupilar de Marcus Gunn

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Tumores de la vía óptica" (6.02.1.026), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.
